EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 85784
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-06-01 11:53:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA MAGDALENA ACUNA GALLARDO			RUN	: 11.567.435-8
F.Nac	: 08-12-1969	Edad	: 54 AÑOS, 5 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: V MUNDIAL N HORIZONTE 0690			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 95938086		
Fecha Ingreso	: 2024-05-24	Fecha Egreso	: 2024-06-01 11:53:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1-Insuficiencia respiratoria aguda Hipoxemica resuelta
2-Neumonia multifocal por parainfluenza + Streptococo Pneumoniae
3-EPOC tabaquico
4-OH/tabaquismo activo
5-Desnutricion severa
6-HTA sistemica

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. B95.3-STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE COMO CAUSA DE ENFER. CLASIF. EN OTR (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente femenina de 54 años, tabaquismo activo y en manejo por APS como EPOC tabáquico desde hace 1 año, quien refiere historia de tos productiva con expectoración amarillenta de larga data, disnea de esfuerzos de mas de 6 meses de evolución. Al interrogatorio dirigido refiere debilidad y perdida de peso de 6 meses de evolución. Acude a urgencias por CEG, hiporexia, mialgias y acentuación de la tos y disnea a pequeños esfuerzos. a su ingreso a urgencias HDM con tendencia a la hipotensión que responde a aporte de volumen, taquicardica, polipneica, con apoyo de O2 a 32%, que progresa a 90% con Pafi 70 por lo que solicitan evolución UPC
TAC de tórax con focos de neumonía multifocal. Exámenes con PCR baja, hoja hepática alterada.Se decide ingreso a UCI para apoyo con CNAF y eventual VMI en caso de falla. Paciente durante estadia en UCI con respuesta favorable a CNAF con posterior titulacion de FIO2 y adecuada mecanica ventilatoria egresando de UCI el 29/5/2024. es trasladada a sala de medicina manteniendose hemodinamicamente estable se logra destete de FIO2 adicional , completa ATB y en vista de encontrarse en estables condiciones se indica alta medica.

PLAN DE MANEJO:

control por consultorio

INDICACIONES AL ALTA

1. 1-Omeprazol 20mg via oral una vez al dia
2. 2-Losartan 50mg via oral cada 12 horas
3. 3-amlodipino 10mg via oral dia
4. 4-Bisoprolol 2.5mg via oral una vez al dia
5. 5-Paracetamol 500mg via oral cada 8 horas SOS

6. 6-Bromuro ipatropio 4 puff c/8horas
7. 7-Salmeterol fluticasona 2 puff c/12h

EXÁMENES Y RESULTADOS

ver ficha clinica

jesus luis antonio perez lozada
MEDICO TRATANTE
26918952-5

JEFE SERVICIO